

# Техническое задание: меню-кнопки, калькулятор анализов и отчёт по работе бота

Клиника «Наука», Самара · 17 августа 2026 · для согласования с заказчиком

## 1. Что предлагается

Сегодня пациент пишет боту свободным текстом, и бот сам угадывает, о чём вопрос. Предлагается добавить в начале диалога **меню из шести кнопок**, которое сразу направляет пациента в нужный сценарий.

Принцип, определивший состав меню: **кнопка называет задачу пациента, а не подразделение клиники**. Пациент знает, что ему нужно («сдать анализы», «узнать цену»), но не обязан знать, лаборатория это или поликлиника.

Вторая часть — **калькулятор стоимости анализов** в режиме «помощник оператора»: бот распознаёт список анализов в сообщении, собирает расчёт и передаёт его оператору. Оператор проверяет состав и одним действием отправляет коммерческое предложение.

Третья часть — **отчёт по работе бота**: сколько обращений, сколько бот закрыл сам, сколько ушло к оператору.

**Территория работы бота: только Самара.** Обращения из других городов переводятся на оператора — это действующее поведение, дополнительных работ не требует.

## 2. Меню: шесть кнопок

| Кнопка                      | Что за ней                                             | Второй уровень                                                                                                                     |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Записаться к врачу</b>   | запись, перенос, отмена, расписание, кто принимает     | Записаться на приём · Когда принимает врач · Перенести или отменить · <b>Подготовка к процедуре</b>                                |
| <b>Сдать анализы</b>        | где и во сколько сдать, нужна ли запись, живая очередь | Где и до сколько принимают · Нужно ли записываться · <b>Как подготовиться к анализу</b> · Подобрать анализы · Сколько стоит анализ |
| <b>Результаты анализов</b>  | получение готового результата                          | Ввести данные · Результат не пришёл · Когда будет готов                                                                            |
| <b>Сколько стоит</b>        | цены на анализы и приёмы, акции                        | Цена анализа · Цена приёма врача · Акции и скидки · Пришлю список — посчитайте                                                     |
| <b>Адреса и часы работы</b> | филиалы, график, как доехать                           | Адреса филиалов · До сколько работаете · Работаете ли в выходные                                                                   |
| <b>Справка в налоговую</b>  | справка для налогового вычета и другие документы       | Справка для вычета · Копия договора, выписка · Больничный лист                                                                     |

Кнопка **«Оператор»** доступна всегда и на любом шаге.

### Почему «Сдать анализы» и «Сколько стоит» — разные кнопки

Вопрос закономерный: и то, и другое кажется «про анализы». Проверка по переписке показала, что это два разных обращения.

**Цена — не только про анализы.** Из 102 диалогов, где заходит речь о стоимости:

| о чём диалог                       | доля |
|------------------------------------|------|
| только про анализы                 | 29%  |
| только про приёмы, УЗИ и процедуры | 29%  |
| и о том, и о другом                | 35%  |

Если убрать цены внутрь кнопки «Сдать анализы», без входа останутся **две трети** ценовых обращений — все, кто спрашивает про стоимость приёма врача или УЗИ.

**Пациенты не задают эти вопросы вместе.** Из 1 920 сообщений пациентов цену спрашивают в 101, «где и во сколько» — в 50. **Оба вопроса в одном сообщении — 2 случая из 101 (1%).** Человек либо выясняет, куда и когда прийти, либо сколько это стоит; в одну реплику он это не соединяет.

**И отвечает на них бот из разных источников.** «Сдать анализы» — это адреса филиалов, график и правило «без записи, живая очередь». «Сколько стоит» — это прайс. Разные данные и разные ответы.

**Связь между темами при этом учтена:** в кнопку «Сдать анализы» добавлен пункт второго уровня «Сколько стоит анализ», который ведёт в тот же ценовой сценарий. Пациент, пришедший от мысли «мне нужны анализы», доберётся до цены, не возвращаясь в главное меню.

**Почему шесть.** Меньше — и без входа остаются адреса и цены, а это самые частые темы обращений. Больше — меню перестает помещаться в один экран телефона. Состав проверен по переписке клиники (259 диалогов WhatsApp):

| тема в переписке пациентов | упоминаний |
|----------------------------|------------|
| записаться                 | 216        |
| адрес                      | 150        |
| подготовка / натошак       | 148        |
| стоимость, цена            | 142        |
| результат                  | 90         |
| справка                    | 12         |

Все шесть формулировок прогнаны через действующего бота — он отвечает на них по существу уже сегодня.

### 3. Почему не «лаборатория» и «поликлиника»

Первоначально обсуждалось деление меню на два отделения. Проверка показала, что как надпись на кнопке эта пара не работает.

**Пациенты так не говорят.** В переписке: «анализ» — 408 упоминаний, «тест» — 31; «лаборатория» — 31, «поликлиника» — 3. Причём все три раза «поликлиника» означает **чужую, государственную**: «засе буду выдвигаться в поликлинику», «принести из поликлиники, др. клиники». Кнопка с таким названием будет понята как «я из госполиклиники». А «лаборатория» у пациента означает **здание**: «в вашей лаборатории», «лаборатория по адресу Стара-Загора, 91».

**Операторы клиники уже задают этот вопрос — и другими словами.** В переписке от 15.11: «Информационный Центр: Вам лаборатория нужна или клиника?» Не «поликлиника».

**Половина тем принадлежит обоим отделениям сразу.** Цены, адреса и подготовка не делятся: прайс общий, филиалы общие. Пациент в режиме «лаборатория», спросивший цену приёма врача,

получил бы отказ вместо ответа.

Развилка «лаборатория / клиника» при этом остаётся полезной **внутри** бота — как способ сузить поиск по прайсу. Это отдельный этап работ (см. раздел 6).

## 4. Подготовка к исследованиям: два разных источника

|                 | Подготовка к анализам        | Подготовка к процедурам                 |
|-----------------|------------------------------|-----------------------------------------|
| Источник        | справочник МИС клиники       | база знаний бота                        |
| Как обновляется | автоматически, ежедневно     | <b>вручную</b> , документ за документом |
| Покрытие        | 1 609 услуг, 99% справочника | требует проверки                        |

**Подготовки к процедурам в справочнике МИС нет.** Проверено поиском по всем 1 613 услугам справочника:

| процедура    | записей в МИС | позиций в прайсе |
|--------------|---------------|------------------|
| <b>УЗИ</b>   | <b>0</b>      | <b>135</b>       |
| колоноскопия | 0             | 2                |
| кольпоскопия | 0             | 3                |
| ЭКГ          | 0             | 2                |

Единственное совпадение по слову «ФГДС» — не сама процедура, а лабораторный профиль «Диагностический профиль перед проведением эндоскопического исследования»: набор анализов крови, которые сдают **перед** эндоскопией.

Причина в природе справочника: **МИС описывает то, что делает лаборатория с материалом.** Что происходит с пациентом до процедуры — знание другого рода, и в выгрузке его нет.

**Практическое следствие.** Кнопка «Как подготовиться к анализу» опирается на автообновляемые данные и работает сама. Кнопка «Подготовка к процедуре» опирается на содержимое, которое заводится в базу знаний руками. **УЗИ — самая частая услуга в переписке пациентов (224 упоминания) и 135 позиций прайса — не имеет подготовки в МИС ни одной строкой.**

## 5. Отчёт по работе бота

### Что требуется

Верхний уровень:

- сколько всего обращений с момента запуска бота;
- сколько закрыто на уровне бота;
- сколько передано оператору.

Разбивка по обращениям, оставшимся на уровне бота:

1. **Успешная сессия** — пациент получил ответ на запрос (ссылка на заполнение справки, ссылка на результат анализа, цена, адрес).
2. **Вопросы, оставшиеся без ответа бота.**

3. **Отказ от оператора** — на предложение переключить пациент ответил «нет». По решению заказчика такая сессия считается **неуспешной**.

#### Что для этого есть сегодня, а чего нет

**Есть:** бот в момент ответа уже знает всё нужное — тему вопроса, выдал ли он содержательный ответ, был ли перевод на оператора и отказался ли пациент от перевода. Все ответы пациенту проходят через одну общую точку, поэтому пометить исход можно в одном месте, не переделывая логику.

**Нет:** бот **не хранит историю обращений**. Память сессии живёт один час и не переживает перезапуск. Никакой базы данных у бота нет — счётчиков за прошлые периоды не существует.

**Следствие, которое важно проговорить заранее:** показатель «с момента запуска бота» ретроспективно из бота получить нельзя. Есть два источника:

- **за прошедший период** — данные системы обработки обращений (мессенджер-шлюз), где диалоги нумеруются и хранятся. Это зона ответственности её команды, запрос надо адресовать им;
- **с даты внедрения отчёта** — полноценный подсчёт с нашей стороны, с разбивкой по всем пунктам выше.

#### Что предлагается сделать

1. **Пометка исхода** каждого ответа в общей точке выхода: тема обращения, выдан ли ответ, был ли перевод на оператора и по какой причине, был ли отказ от перевода.
2. **Накопление** этих пометок в суточные файлы на сервере — база данных не нужна.
3. **Сборка отчёта** за произвольный период: три верхних показателя и разбивка по трём категориям, в виде таблицы.
4. **Закрывающий вопрос** «Вы получили ответ на свой вопрос?» — оценивается отдельно, см. ниже.

#### Про закрывающий вопрос

Пожелание заказчика — чтобы бот спрашивал, получил ли пациент ответ, и по ответу определялась успешность сессии. Реализуемо, но с оговоркой: если задавать такой вопрос после каждого ответа, он быстро начинает раздражать и удлиняет диалог.

Предлагается задавать его **только после содержательного завершения** — когда бот выдал конкретный результат (ссылку на справку, ссылку на результат, цену, адрес), и **не задавать** после уточняющих вопросов и в середине оформления записи.

Пункт вынесен в смету отдельной строкой, чтобы его можно было отложить: базовый отчёт считается и без него, по фактическому поведению пациента.

---

## 6. Объём работ и сроки

| работа                                  | часов        | что даёт                                                                                            |
|-----------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Меню из шести кнопок</b>             | <b>12–30</b> | стартовое меню и второй уровень, показ в начале диалога и при затруднении                           |
| <b>Отчёт по работе бота</b>             | <b>24–46</b> | пометка исхода, накопление, сборка отчёта за период                                                 |
| Закрывающий вопрос «Вы получили ответ?» | +8–16        | подтверждение успешности от самого пациента                                                         |
| <b>Калькулятор, базовый объём</b>       | <b>33–66</b> | распознавание списков и коротких обозначений (Т3, Т4, В12), выбор базовой цены, сумма, взятие крови |
| Калькулятор, полный объём               | 54–105       | то же + передача расчёта оператору и файл предложения                                               |
| Сужение поиска по теме                  | 30–54        | отдельный этап: лаборатория/клиника внутри поиска по прайсу                                         |

### Что помещается в 1,5 месяца

Бюджет 1,5 месяца — около **99 часов**.

| набор                                | часов        | вердикт                               |
|--------------------------------------|--------------|---------------------------------------|
| Меню + отчёт                         | <b>36–76</b> | <b>помещается с запасом</b>           |
| Меню + отчёт + закрывающий вопрос    | <b>44–92</b> | <b>помещается</b>                     |
| Меню + калькулятор (базовый)         | 45–96        | помещается                            |
| Меню + отчёт + калькулятор (базовый) | 69–142       | помещается только по нижней границе   |
| Всё вместе с полным калькулятором    | 90–181       | не помещается, требуется 2–2,5 месяца |

**Предлагается зафиксировать в 1,5 месяца: меню, отчёт и закрывающий вопрос (44–92 часа).**

Калькулятор выносится следующим этапом — на него требуется отдельно около месяца, и его полный объём в любом случае зависит от смежной команды.

Если приоритет заказчика — калькулятор, то в 1,5 месяца помещается связка «меню + калькулятор», а отчёт переносится на следующий этап. Одновременно все три блока в 1,5 месяца не помещаются.

### Что входит в часы, а что нет

**Входит:** разработка, автоматические проверки на каждом шаге, контрольный прогон качества бота.

**Не входит:** работы на стороне мессенджер-шлюза — отрисовка кнопок в Telegram/WhatsApp, передача расчёта оператору, выгрузка исторических данных по обращениям. Это другая команда и отдельная оценка. **Без них калькулятор в полном объёме и показатель «с момента запуска» не закрываются независимо от готовности бота.**

### Вопросы, от которых зависит срок

Без ответов бот не вправе выбирать за пациента и будет переспрашивать:

1. **«Т3» и «Т4» — свободный или общий?** В прайсе четыре позиции с разными ценами: сТ3 — 410 руб., сТ4 — 400 руб., общий Т3 — 380 руб., общий Т4 — 380 руб.
2. **Добавлять ли «Взятие крови из вены» автоматически?** Позиция отдельная и платная, в прайсе три варианта: из вены — 195 руб., из пальца — 180 руб., без последующего исследования — 190 руб.
3. **Какой вариант услуги считать базовым?** У общего анализа крови пять позиций: 390 руб., «полный» 550 руб., капиллярная 380 руб., 500 руб. и срочная (Cito) 580 руб.

4. **Заведена ли в базу знаний подготовка к УЗИ, ФГДС и колоноскопии** и кто отвечает за её актуальность (см. раздел 4)?
5. **Результаты анализов сейчас выдаются пациентам из любого города** — портал результатов не привязан к региону. Сохранять ли это исключение при правиле «только Самара»?